

TRAUMATISMOS Y LESIONES MÁS FRECUENTES DEL DEPORTISTA - MMSS



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

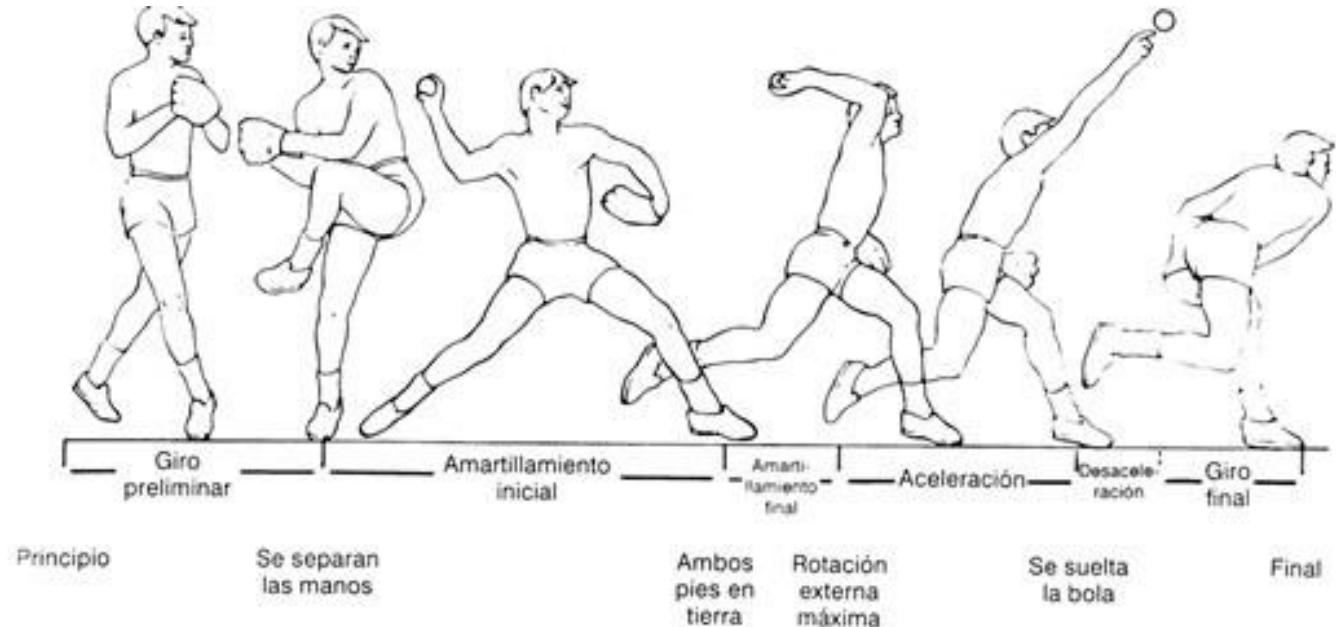
EL HOMBRO DEL LANZADOR

Los deportistas que realizan lanzamientos supracefálicos repetidos pueden padecer lesiones específicas en el hombro. Estas lesiones de los lanzadores supracefálicos suelen afectar al labrum y al manguito rotador. Los cambios de la cápsula glenohumeral anterior y posterior se producen con estos movimientos repetidos, en relación con alteraciones neuromusculares, a veces difíciles de diagnosticar. La articulación gleno-humeral y la escápula constituyen una unidad, por lo que vamos a analizar los problemas escapulares del lanzador que pueden provocar una lesión de las partes blandas de la articulación del hombro.



ACTO DE LANZAR

Con el tiempo, la repetición de este movimiento producen una respuesta de reparación fibrosa del manguito rotador y de la cápsula articular que llegan a producir rigidez capsular



PATOMECANICA DEL LANZAMIENTO

LAXITUD CAPSULAR ANTERIOR

La cápsula anterior de la articulación gleno-humeral, en particular el fascículo anterior del ligamento glenohumeral inferior, ejerce la principal contención para que la cabeza del húmero se traslade hacia delante con el brazo abducido y rotado externamente

CONTRACTURA CAPSULAR POSTERIOR

Con el tiempo, se presenta menor rotación interna del hombro, sobre todo si se mide en abducción. Debido a:

- Mayor retroversión humeral que produce una pérdida de rotación interna que se produce por la remodelación ósea y va acompañada del aumento simétrico de rotación externa. Este “reajuste del reloj” de la rotación es el responsable de una pérdida de la rotación interna nunca superior a 10° - 17° .
- Contractura de la cápsula posterior con retracción del manguito rotador. El déficit de rotación interna gleno-humeral (GIRD).

DIAGNOSTICO

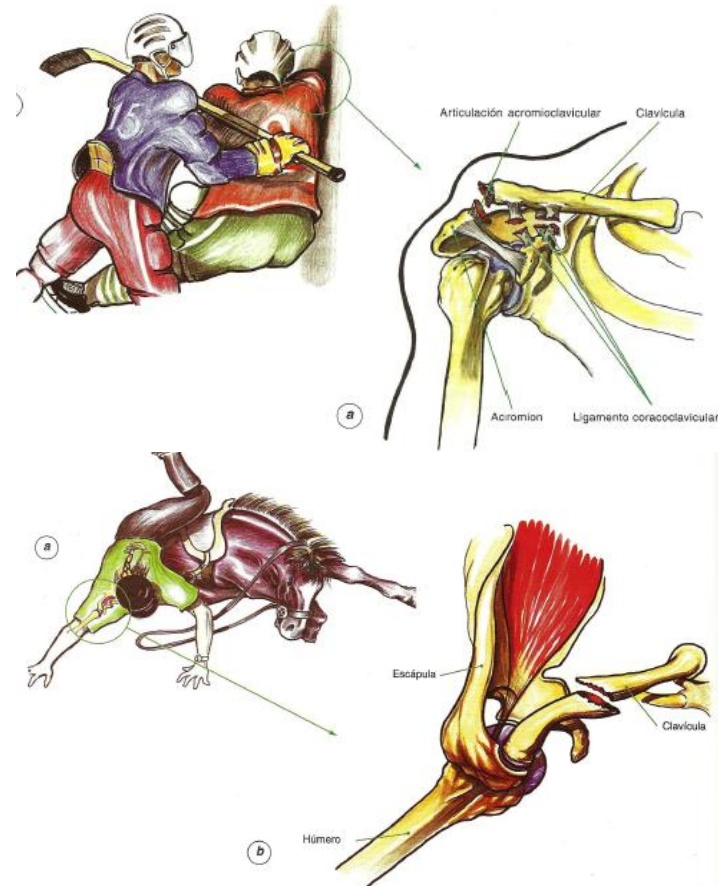
- Dolor, pérdida de velocidad o control o síntomas mecánicos de chasquidos o bloqueos.
- Sensibilidad posterior, que puede reflejar un desgarró del labrum posterior o irritación posterior del manguito rotador.
- Dolor anterior a la palpación, menos frecuente, puede indicar trastornos del labrum anterior o una lesión del m. supraespinoso.
- Dolor anterior o medio que cursa en la región subpectoral es coherente con una patología del tendón largo del m. bíceps braquial. El dolor nocturno, especialmente cuando se está recostado sobre el hombro, suele reflejar una lesión del manguito rotador.

- La pérdida de “energía” o la incapacidad para “encontrar el ángulo idóneo” durante el lanzamiento puede ser el resultado de un daño en el labrum o del manguito rotador con la consiguiente anormalidad mecánica.
- Rotura de la cadena cinética puede provocar un control errante. Como la pérdida de rotación interna de la pierna dominante puede causar que el lanzador tenga que abrirse prematuramente durante la fase final de preparación, generando de ese modo una pérdida de precisión en el tiro.
- “brazo dormido” repentino durante la fase final de preparación o después de un único tiro que provocó una cantidad desmesurada de dolor. Indica una lesión glenoidea tipo SLAP (Superior Labrum Anterior and Posterior) o un fallo mecánico de las fibras.

FRACTURA CLAVICULAR

- Son lesiones frecuentes producto de un golpe directo.
- Se clasifican en mediales y laterales.
- En las fracturas laterales de clavícula, el traumatismo suele ser directo sobre el tercio distal, como sucede con las lesiones de la articulación AC.

Diagnóstico: Rx simple.



TRATAMIENTO

FRACTURAS MEDIALES

- La mayoría son de tratamiento relativamente fácil.
- Se recurre a un vendaje en ocho o un collar acolchado cuando es necesario aliviar el dolor, mas no para reducir la Fx.
- La Cx es poco frecuente en Fx agudas, excepto en los casos de lesiones abiertas (compuestas).
- Las lesiones con desplazamiento curan con acortamiento y presentan una protuberancia (callo) sobre el sitio de Fx, lo cual no ocasiona problemas funcionales.



TRATAMIENTO

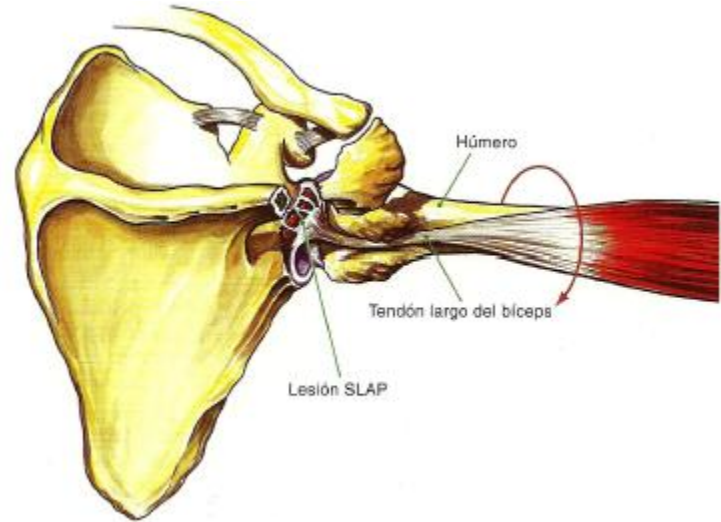
FRACTURAS LATERALES

- En el primer nivel de asistencia, el tratamiento de Fx estables es conservador.
- Cuando existe desplazamiento, la Cx puede ser necesaria dado que este tipo de Fx suele curar con dificultad y presentan mayor riesgo de pseudoartrosis.
- El pronóstico de las Fx es favorable y el deportista debe prever que recuperará su nivel previo de actividad sin inconvenientes, sin embargo, pueden presentar secuelas de dolor e impotencia funcional.



LESIONES DE LABRUM: SLAP

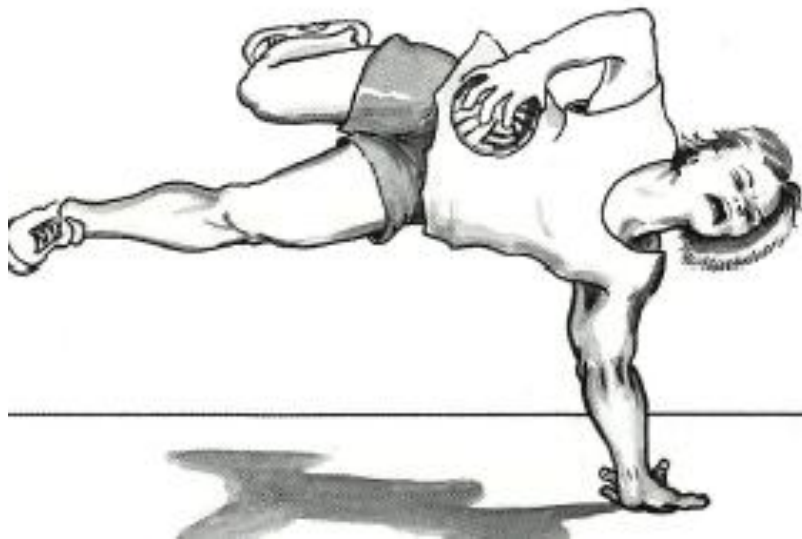
- Se produce cuando el paciente sufre una caída sobre el brazo extendido o es sometido a una contracción excéntrica intensa que involucra la cabeza larga del bíceps braquial
- El complejo tendinoso labrum – bíceps puede resultar desprendido de la porción superior de la cavidad glenoidea, lo que ocasionará una lesión superior del labrum en dirección anteroposterior (SLAP).

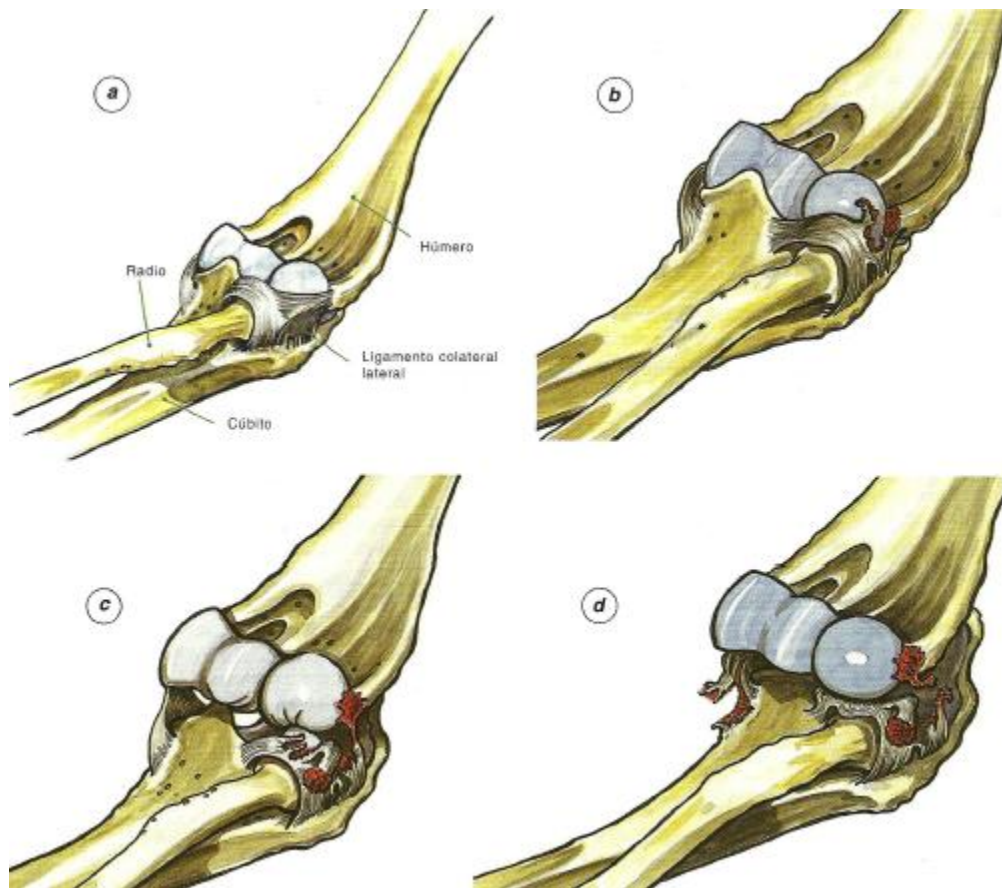


- **Síntomas y signos:** Los pacientes suelen manifestar dolor en la parte superior o posterior del hombro, principalmente en los movimientos de rotación externa y abducción. Sensación de inestabilidad, deslizamiento o chasquido en la articulación.
- **Dx:** anamnesis y exploración física, presentándose inestabilidad anterior y estudios por imágenes.
- **Tratamiento:** los pacientes suelen ser derivados para realizar una artroscopia de hombro y una eventual reparación quirúrgica de la lesión.
- **T. fisioterapéutico:** entre distintos modos terapéuticos, es necesaria restringir la carga excéntrica del tendón largo del bíceps durante 6 – 8 semanas post Cx.
- **Pronóstico:** Bueno.

ESGUINCE DE LIGAMENTO LATERAL: LUXACIÓN DE CODO

- Se producen habitualmente por caída sobre el brazo en extensión.
- Pueden clasificarse de acuerdo a la magnitud de la inestabilidad articular asociada.
- Las rupturas parciales probablemente originen varias entidades dolorosas en la parte lateral del codo después de un traumatismo leve, como la lesión por hiperextensión.

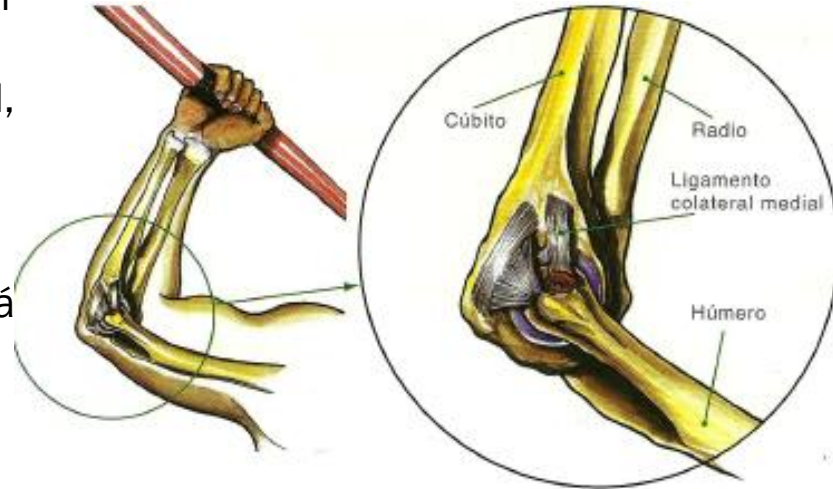




- **Síntomas y signos:** las lesiones de grado I producen inflamación, hipersensibilidad y equimosis ocasional por encima del epicóndilo. Las lesiones de grado III producen desviación y limitan notablemente la amplitud de movimiento. En este grado es imposible excluir Fx asociadas.
- **Dx:** es clínico, aunque las Rx AP y lateral clásicas son necesarias para descartar Fx.
- **Tratamiento médico:** en lesiones de grado I y II no requieren inmovilización y son tratadas mediante ejercicios de amplitud activos dentro de los límites del dolor, entrenamiento de fuerza y protección contra nuevos traumatismos.
- **T. fisioterapéutico:** El paciente deberá aprender un programa de ejercicios para realizar en el hogar que respete los límites del dolor. Evitar estiramientos pasivos. Los ejercicios de fuerza deben iniciarse cuando se haya alcanzado la amplitud de movimiento aceptable o total.

RUPTURA DEL LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL

- La causa más frecuente es el esfuerzo en valgo. Por ejemplo: lanzamiento (jabalina, béisbol, balonmano), hiperextensión (porteros) o caídas.
- En la mayoría de casos, el ligamento está parcialmente desgarrado.
- También pueden producirse junto con fracturas o luxaciones.



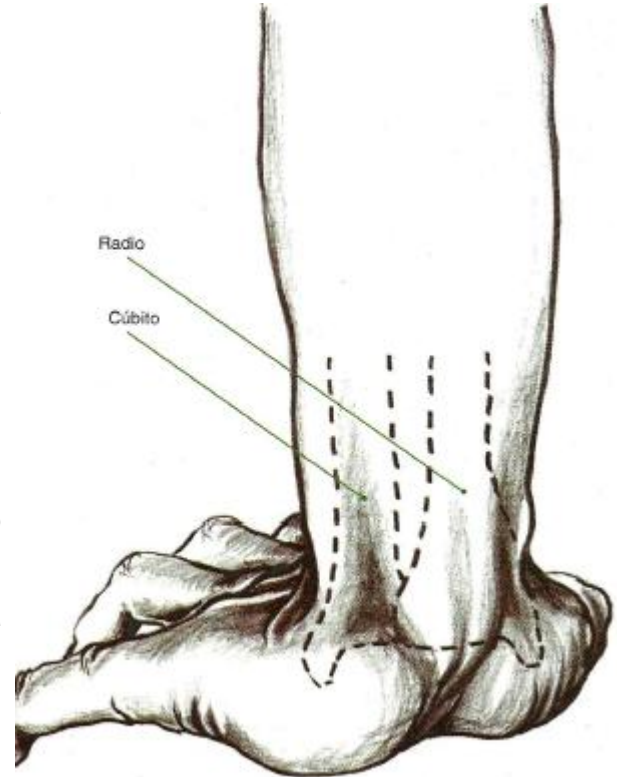
- **Síntomas y signos:** principal síntoma es el dolor en la región media del codo con la actividad.

La hipersensibilidad focal con la palpación y el dolor con el estrés en valgo constituyen los hallazgos principales.

- **Dx:** clínicamente, mediante prueba de esfuerzo en valgo. También se requiere evaluación mediante Rx para descartar Fx.
- **Tratamiento:** aplicación del método PRICE (inicial).

ESGUINCE DE MUÑECA

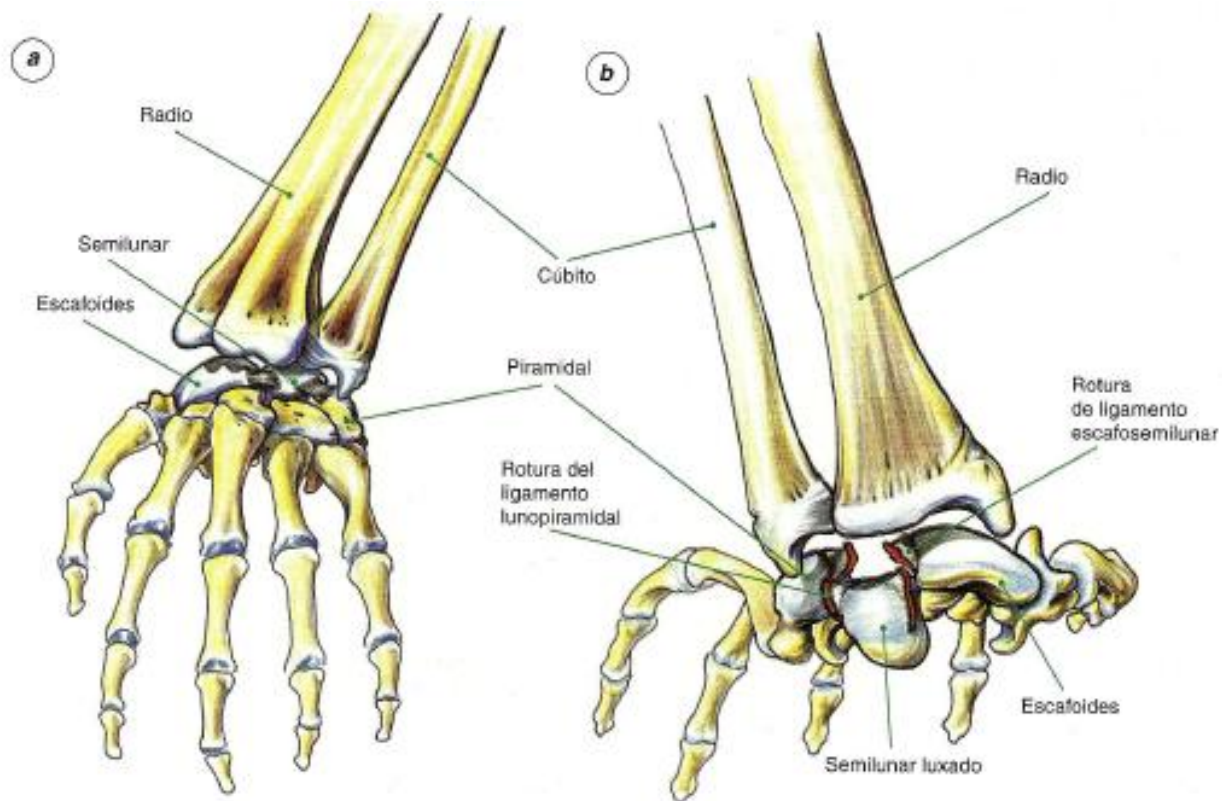
- Ocasionado por caída sobre la mano extendida, el golpe directo o la torsión de la muñeca.
- Produce contusión de tejido blando o lesión de la cápsula articular.
- La mayoría de personas que se caen no consultan al médico porque sus síntomas son moderados y generalmente transitorios.



- **Síntomas y signos:** se experimenta dolor, hipersensibilidad, tumefacción y ROM limitada.
- **Dx:** cuando el dolor y la tumefacción no mejoran en una semana, se deben solicitar estudios radiológicos convencionales
- **Tratamiento:** aplicación del método PRICE con AINEs y posible inmovilización con yeso.
- T. fisioterapéutico: se puede vendar al paciente o adaptar

LESIÓN LIGAMENTOSA DE MUÑECA

- Se da cuando la mano recibe un golpe fuerte, generalmente ocasionado por la mano hiperextendida, desviada hacia la cara cubital y con rotación leve.
- Esto puede ocasionar una Fx.
- El diagnóstico suele ser difícil.
- Las lesiones más frecuentes se producen en los ligamentos escafosemilunar y lunopiramidal.



- **Síntomas y signos:** dolor e inflamación, hipersensibilidad y restricción en la amplitud de movimiento.
- **Dx:** identificación de la zona de inestabilidad e hipersensibilidad resultante en la muñeca.
Durante la fase aguda es difícil la evaluación porque “duele todo”.
- **Tratamiento:** debe derivarse a un Cx de mano. Generalmente, el Tto Qx comprende la ubicación, fijación ósea y reparación de ligamentos.
- **Pronóstico:** el Tto permite el restablecimiento de la anatomía normal con buena evolución.

ARMENIA

BBC NEWS | MUNDO

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

ACTIVIDAD: LESIÓN DE BANKART

GRUPO 1:	GRUPO 2:	GRUPO 3:	GRUPO 4:
Definición y mecanismo de lesión Angasi Poma Pardo Rivera Pérez	Sintomatología y reparación •Mamani •Neyra •Guerrero •Vera •Romero	Pruebas de imágenes necesarias y pruebas ortopédicas •Quispe •Oblea •Ramírez •Dueñas •Yataco	Tratamiento: agentes físicos (¿Por qué y para qué los utilizo?). Ejercicios en una fase avanzada (Qué músculos busco reforzar) •Agurto •Huarca •Flores •Nolasco